Tràn khí màng phổi áp lực

*Đánh giá toàn diện: Thg 4 2024 Theo **Thomas G. Weiser**, MD, MPH, Stanford University School of Medicine | Được bình duyệt bởi **David A. Spain**, MD, Department of Surgery, Stanford University*

Cập nhật lần cuối: Thg 4 2024

> **Tràn khí màng phổi áp lực là sự tích tụ khí trong khoang màng phổi dưới áp lực, chèn ép phổi và làm cản trở tĩnh mạch về tim.**

(Xem thêm Tổng quan về Chấn thương ngực.)

Tràn khí màng phổi dưới áp lực phát triển khi một tổn thương phổi hoặc thành ngực làm cho không khí vào khoang màng phổi nhưng không ra được (van một chiều). Do đó, khí tích tụ và chèn ép phổi, cuối cùng đè đẩy trung thất, phổi đối diện, và tăng áp lực trong ngực làm giảm máu tĩnh mạch đổ về tim, gây sốc. Những ảnh hưởng này có thể tiến triển nhanh, đặc biệt ở bệnh nhân đang thở máy áp lực dương.

Nguyên nhân bao gồm thở máy (thường gặp nhất) và tràn khí màng phổi đơn thuần (không biến chứng) có tổn thương phổi mà vết thương không bịt kín sau vết thương thấu ngực hoặc chấn thương ngực, hoặc đặt ven tĩnh mạch trung ương thất bại.

Các triệu chứng và dấu hiệu của khí màng phổi áp lực

Các triệu chứng và dấu hiệu ban đầu là những triệu chứng của tràn khí màng phổi đơn thuần. Khi áp lực ngực tăng lên, bệnh nhân sẽ tụt huyết áp, đẩy lệch khí quản và giãn tĩnh mạch cổ. Lồng ngực tổn thương gõ vang hơn và thường cảm thấy hơi căng, xẹp ít khi hô hấp.

Chẩn đoán tràn khí màng phổi áp lực

- Bệnh sử và khám lâm sàng

Tràn khí màng phổi dưới áp lực cần được chẩn đoán dựa vào dấu hiệu lâm sàng. Không nên trì hoãn điều trị để chờ kết quả X-quang. Mặc dù chèn ép tim cũng có thể gây tụt huyết áp, giãn tĩnh mạch

cổ, và đôi khi có suy hô hấp, tràn khí màng phổi dưới áp lực có thể được phân biệt được bằng lâm sàng bởi giảm tiếng rì rào phế nang và gõ vang.

Điều trị khí màng phổi áp lực

- Dùng kim giảm áp sau đó là dẫn lưu màng phổi

Điều trị tràn khí màng phổi áp lực là giảm áp lực ngay lập tức bằng kim bằng cách đưa kim có lỗ lớn (ví dụ: 14 gauge hoặc 16 gauge) vào khoang liên sườn thứ hai trên đường giữa đòn. Hỗ trợ cuộc sống chấn thương nâng cao của Hiệp hội Phẫu thuật Hoa Kỳ khuyến nghị đặt vào khoang liên sườn thứ tư hoặc khoang liên sườn thứ năm dọc theo đường nách giữa, vì nó có liên quan đến việc cải thiện thành công trong việc giảm áp. Không khí sẽ tràn ra. Bởi vì sự giảm áp bằng kim gây ra một tràn khí màng phổi đơn thuần nên phải thực hiện dẫn lưu màng phổi ngay sau đó.

Tràn khí màng phổi áp lực

HÌNH ẢNH



Trong hình ảnh này, tràn khí màng phổi có thể nhìn thấy ở nửa lồng ngực phải, ở đó, ở vùng ngoại vi, không có các dấu ở phổi. Dịch chuyển tim và trung thất về phía bên trái có thể gây sinh lý tràn khí màng phổi áp lực. Tuy nhiên, tràn khí màng phổi áp lực, nên được chẩn đoán bằng lâm sàng và không cần chờ xác nhận bằng X-quang.

DU CANE MEDICAL IMAGING LTD/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC

Ngọc trai & cạm bẫy

- Tràn khí màng phổi dưới áp lực được chẩn đoán ngay tại giường dựa trên các dấu hiệu lâm sàng và được điều trị ngay bằng kim giải ép và/hoặc dẫn lưu màng phổi.

MSD

Bản quyền © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA và các chi nhánh của công ty. Bảo lưu mọi quyền.

Cách thực hiện thủ thuật mở th...

CÁC VIDEO



Mở lồng ngực dẫn lưu như thế n...

CÁC VIDEO

